

04 - 04- L'œil rouge - Pr. MOUTAOUAKIL

Bonjour, l'œil rouge constitue un ensemble d'étiologies qui se résume sur le plan clinique en un œil rouge. Un œil rouge nécessite un bilan étiologique, un diagnostic précis. Nous allons aborder ce cours en étudiant les objectifs qui sont les objectifs à adopter pour, devant un œil rouge, une introduction, un diagnostic positif, un diagnostic étiologique, avant de conclure.

Donc quels sont les objectifs pour ce cours ? C'est d'énumérer les étiologies d'un œil rouge, c'est ça le plus important, s'orienter vers une étiologie par un interrogatoire, par un examen non spécifique, et définir le degré d'urgence. Cet œil rouge doit être pris en charge tranquillement ou doit être adressé le plus vite possible à un ophtalmologiste. Citer les examens réalisés en urgence et expliquer le pronostic de certaines pathologies qui sont liées à cet œil rouge.

L'œil rouge est un symptôme qui est fréquent en ophtalmologie, son diagnostic positif est simple, les signes d'accompagnement doivent être bien étudiés, et l'examen clinique précis permettra de s'orienter vers une étiologie. Il traduit une pathologie qui peut être bénigne, comme la conjonctivite, mais parfois grave, qui peut menacer le pronostic fonctionnel, comme le glaucome, qui est une urgence répétitive. Le diagnostic positif va se faire en s'intéressant à l'examen méthodique de l'œil et de la région palpébrale de façon bilatérale et comparative.

La conjonctive, on doit regarder la rougeur, est-ce qu'elle est diffuse, la rougeur est-ce qu'elle est focalisée, au pourtour de la cornée ou dans les cul-de-sac conjonctivaux. La cornée, est-ce qu'il y a une perte de transparence, est-ce qu'il y a un corps étranger, et la pupille, est-ce qu'elle est en miosis ou est-ce qu'elle est en dilatation. Le tonus oculaire doit être aussi apprécié.

Alors l'interrogatoire est un élément très important dans le diagnostic d'un œil rouge. Antécédents ophtalmologiques et généraux, chirurgie, traumatisme, installation de colliers, lentilles, de contacts, infection ORL, simultanée, allergie, les circonstances d'apparition brutale ou après un stress, un glaucome aigu, progressive, c'est une inflammation, accidentelle c'est un traumatisme, contexte épidémique, une conjoncture, les signes fonctionnels associés, est-ce qu'il y a une douleur oculaire, c'est témoin d'une gravité, l'agglutination matinale décène par des sécrétions, la baisse de l'acuité visuelle, la photophobie, le spasme palpébral, le larmement, qui sont des signes irritatifs, et la rougeur observée par l'entourage. L'examen clinique va s'intéresser d'abord à l'acuité visuelle, à chiffrer, inspection, la topographie de la rougeur, est-ce qu'elle est au niveau des culs de ses conjonctivaux, est-ce qu'il y a une hémorragie sous-conjonctivale, est-ce qu'il y a un cercle péricératique qui témoigne d'un glaucome, d'une kératite ou d'une uvéite, l'examen de la conjonctive bulbaire plus palpébrale à la recherche d'un corps étranger, le segment antérieur va s'intéresser à la corne, est-ce qu'elle est opaque, ulcération, grâce au test à la fluoresceine et la sensibilité.

La chambre antérieure, on va apprécier sa profondeur, on va apprécier le contenu, est-ce qu'il y a un épanchement, est-ce qu'il y a un éphéma, est-ce qu'il y a un tendon, l'iris, on va chercher la

forme de la pupille, le réflexe photomoteur et le tonus oculaire. Il faut chercher les signes de gravité, et quels sont les signes de gravité ? Les signes de gravité peuvent être une baisse de l'acuité visuelle, douleur oculaire, un cercle péri-kératique, un test à la fluoresceine positive, un épopéon, un éphéma, une hémertonie oculaire, une anomalie de la pupille, le port de lentilles de contact, traumatisme ou un post-opératoire, c'est d'une gravité énorme, symptômes systémiques, nausées, vomissements, encéphalées sévères. Alors, nous allons classer cet œil rouge en différentes étiologies.

On va parler de l'œil rouge indolore sans baisse de l'acuité visuelle, puis on va parler de l'œil rouge douloureux sans baisse de l'acuité visuelle, pour enfin terminer avec l'œil rouge douloureux avec baisse de l'acuité visuelle. Nous allons partir des choses les plus bénignes vers les choses les plus graves qui s'accompagnent d'une douleur et d'une baisse de l'acuité visuelle. Alors, l'œil rouge indolore sans baisse de l'acuité visuelle, nous commençons par l'hémorragie sous-conjonctive.

C'est une infection qui est banale, sans gravité, placard rouge en nappe, localisé ou étendu sous le vent de la conjonctive. L'état de la corne, la chambre antérieure et la pupille sont normaux. Le fondet va rechercher des signes en rapport avec une pathologie générale prédisposante.

L'étiologie peut être traumatique, banale, mais peut masquer une lésion plus grave. Il faut toujours, toujours, toujours avoir la hantise de rechercher une plaie du globoculaire, un corps étranger, lésion de segments antérieurs et poissonnières, évocatrice de la plaie. L'hyperpression veineuse, soit à cause d'un traumatisme thoracique ou d'une quinte de toux.

La couche, par exemple, accouchement difficile, accident de décompression, la strangulation. Il peut être aussi, cette hémorragie peut être spontanée, les facteurs favorisants sont l'hypertension artérielle, le diabète, les troubles de la coagulation, la fragilité vasculaire. En général, ces hémorragies sous-conjonctives ou évoluent vers la régression spontanée en une dizaine de jours sans traitement.

Deuxième étiologie de l'œil rouge, une douleur sans baisse de la vision est les conjonctivites. Et qui dit les conjonctivites dit un ensemble hétérogène qui regroupe plusieurs étiologies. Nous allons commencer par les conjonctivites bactériennes, une rougeur conjonctivale diffuse prédominant d'un aiguillon du cercle, le plus souvent elle est bilatérale, parfois à l'intervalle libre, l'acuité visuelle est conservée, il n'y a pas de véritable douleur, mais il y a plutôt une sensation de grande douceur et les sécrétions mucopurulentes qui collent les cils le matin sont très caractéristiques.

Le prélèvement n'est pas nécessaire, le plus souvent c'est des germes grampositifs qui sont responsables, ils ont une antibiothérapie pendant sept jours avec l'hygiène des cils et des paupières permet une évolution favorable avec régression complète de la symptomatologie. Les conjonctivites virales à adénovirus très fréquentes, très contagieuses, ils surviennent, se font d'épidémies, ils sont symétriques et bilatérales, incubation de 2 à 8 jours, sécrétions claires.

Nous avons parfois une adénopathie très tragique, très caractéristique, très évocatrice.

Nous avons des manifestations OADN associées avec une kératite sous-épithéliale, les opacités numéraires à l'origine de la baisse de l'acuité visuelle, le traitement répond essentiellement au traitement antibiotique parce que la seule infection survient en général. Les corticoïdes c'est une affaire de médecin spécialiste, il peut les prescrire en fonction de l'existence de kératite sous-épithéliale, il faut l'arrêt du travail, l'éviction scolaire, l'hygiène d'AIMLA qui sont très très importantes. La conjonctivite aclairidienne, il y a deux types, il y a les chroniques aclairidiennes qui sont essentiellement ce qu'on appelle des conjonctivites aclairidiennes de piscine qui deviennent de plus en plus rares, le trachomocie qui a vu son incidence dans notre pays diminuer de façon très importante alors qu'il constituait auparavant une cause de cécité majeure dans notre pays et qui débute par une conjonctivite qui évolue vers une atteinte cornéenne, vascularisation de la cornée, le palmus trachomato avec des signes de trichiasis ça veut dire une éversion de la paupière vers le dedans avec des cils qui frottent sur la cornée et des ulcères et des surinfections qui donnent la cécité, heureusement qu'actuellement on ne voit plus ces formes de trachomocies, voilà des lésions trachomatoes au niveau de tarses avec des atrophies conjonctives en regard de tarses, voilà des follicules des follicules qui s'observent au cours donc de trachos.

Il y a eu donc une organisation mondiale avec l'organisation mondiale de la santé qui a défini la stratégie chance, cette stratégie chance se base essentiellement sur la chirurgie, chirurgie de trichiasis éviter les complications du trachos, l'antibioprophylaxie, l'antibiothérapie qui est utilisé essentiellement un antibiotique qui peut être donné en une seule fois qui est l'azithromycine, le nettoyage du visage et le changement des habitudes environnementaux, surtout avoir l'eau à côté de la population, cette stratégie chance a permis de réussir le défi de vaincre le trachomocie au niveau de tout le Maroc, essentiellement au niveau des provinces dont la prévalence était très très importante. Nous passons à un autre type de conjonctivites, les conjonctivites allergiques. Il faut savoir qu'au cours des conjonctivites allergiques aucun symptôme n'est spécifique, mais les circonstances de l'intérêt de l'interrogatoire, la survenue, les signes extraoculaires, l'interrogatoire essentiel permettent de s'orienter vers la cause allergique.

Au cœur de l'allergie on retrouve cette fameuse cellule qui est l'histamine et cette cellule est responsable pratiquement de toutes les manifestations qui vont accompagner la conjonctivite allergique. Une fois l'allergie va se fixer sur les récepteurs, il y aura donc une dégranulation de ces masses d'oxygène et c'est cette dégranulation qui va libérer l'histamine et l'histamine qui va provoquer toutes les réactions inflammatoires, l'œdème, l'inflammation, la vasodilatation, toute la symptomatologie de l'allergie. Donc si on va agir sur le plan thérapeutique, on doit absolument agir sur cette histamine ou agir sur cette dégranulation au niveau de ces masses d'oxygène qui vont donc provoquer cette réaction.

Alors les classifications des conjonctivites allergiques, je vous passe rapidement ceci pour vous dire qu'il en existe plusieurs types, les conjonctivites isonières, les conjonctivites perannuelles,

les keratoconjonctivites virales, très difficile à traiter, les keratoconjonctivites atypiques et les conjonctivites gigotopapillaires. Les conjonctivites allergiques aiguës et isosensitives sont dues essentiellement aux EGI, symptomatologie périodique mais limitée, la plus fréquente, manifestations sont épuisantes, les conjonctivites sont prurigineuses, ils surviennent sur un terrain allergique, asthme, otite allergique associée. Les allergènes souvent rencontrés sont les pollens, les moisissures et les allergènes alimentaires.

Voilà un exemple typique d'une conjonctivite allergique. La perannuelle ou la chronique c'est une symptomatologie qui est toute l'année avec des recrudescences saisonnières. Les symptômes sont modérés, vous avez les papilles, les allergènes ce sont les hexacarpiens, les domestiques, les blattes, les moisissures, les plantes, les fongues pardon, les animaux, les allergènes professionnels.

Et les keratoconjonctivites vernoales qui est une maladie de l'enfance, qu'on dit souvent qu'il va disparaître vers l'âge de la puberté, c'est une conjonctivite papillaire géante ou une inflammation de la brique. Les symptômes sont intenses, les poussées sont plus fréquentes, il survient essentiellement au niveau du printemps à l'automne, c'est pour ça qu'on l'appelle, certains l'appellent la printanière. L'allergie est inconstante et l'allergène n'est pas encore retrouvée.

Les keratoconjonctivites atypiques survient sur des terrains bien particuliers, dermatite atopique, eczéma ou asthme chez des personnes adultes avec des complications assez redoutables. La gigantopapillaire par contre est une conjonctivite qui survient chez les porteurs de lentilles, c'est un conflit mécanique avec des phénomènes immunitaires, c'est les lentilles souples qui sont plus souvent responsables, une symptomatologie très épuisante. On retrouve donc ces conjonctivites très importantes avec des papilles géantes qu'on va retrouver dans ces pathologies.

Alors, nous avons terminé avec l'œil rouge indolore sans baisse de l'acuité visuelle, nous allons passer maintenant à l'œil rouge douloureux sans baisse de l'acuité visuelle. Il y a deux étiologies essentielles dans cette rubrique. Il y a les épisclérites qui correspondent à l'inflammation de l'épisclaire située directement au-dessous de la conjonctive, sur le plan clinique c'est une douleur minime, rougeur localisée avec des dilatations des vaisseaux épiscléraux, il disparaît après installation d'un vasoconstricteur.

Évolution générale est banale, elle régresse sans séquelles sous anti-inflammatoire non-stéroïdien local ou général. Voilà une épisclérite, regardez, elle est localisée avec des dilatations des vaisseaux sous conjonctive. Voilà un autre aspect de l'épisclérite avec des dilatations des vaisseaux.

Par contre l'esclérite, la clinique, il y a une douleur profonde, majeure, majorée par la mobilisation du globe. La rougeur oculaire est localisée avec une petite rosace, ce qui témoigne que l'esclère participe à cette inflammation. Elle ne disparaît pas à l'installation d'un vasoconstricteur et il y a le DEMP sclérale associé.

Les étiologies peuvent être générales, articulaires pour les arthralgies, les vascularites, les granulomateuses, les causes infectieuses comme vous les voyez dans toutes les pathologies, les post-traumatiques accidentelles ou chirurgicales. L'évolution traduit une pathologie grave à rechercher systématiquement. Le traitement est essentiellement étiologique.

Les anti-inflammatoires en première intention, en cas de mauvaise réponse, il faut utiliser les corticoïdes, voire les immunosuppresseurs dans certains cas. L'absence de contexte traumatique, nous sommes devant un oeil rouge douloureux avec baisse de l'acuité visuelle. Lorsqu'on a l'absence du contexte traumatique, présence du contexte traumatique, l'absence de contexte traumatique, on a le glaucome aigu par fermeture de la pupille.

C'est une urgence ophtalmologique majeure. Pour nous c'est élevé de courir, c'est une maîtrise à réflexion. La kératite aiguë, douleur oculaire, photophobie, kératite herpétique dendritique.

Attention, les corticoïdes sont contre-indiqués, un retard de la cicatrisation, mais en plus, ils peuvent donner une perforation du globe oculaire. Les herpétyclites, douleur oculaire, photophobie, myosis, stendhal, les causes locales et générales, maladie de B7 par exemple. Donc nous commençons par les kératites.

La kératite aiguë, douloureuse avec baisse de l'acuité visuelle, douleur vive, cercle péri-kératique, testes à la fluoresceine, kératite épithéliale, ulcère superficiel, kératite interstitielle, fluo-nigratif, ou prostate stromale, eux-mêmes connaissent sa perte de substances épithéliales. Les kératites épithéliales, l'érosion cornéenne, kératite herpétique, la zoostérie et les kératites bactériennes. Les lésions cornéennes, elles peuvent se voir en détachement avec solidement, traumatisme bénin, douleur vive, larmement, sensation de corps étranger, testes à la fluoresceine, on a une zone de désépithélialisation.

Il faut toujours renverser la paupière à la recherche d'un corps étranger. Traitement, collyre antiseptique, antibiotiques, cicatrisant, cornéenne. Les kératites épithéliales herpétiques, pronostic visuel mis en jeu, opacification de la cornéenne, isolée ou atteinte cutanéomuqueuse, le test de la fluoresceine va retrouver cet aspect caractéristique d'ulcère dendritique ou en carte géographique ou kératite ponctuée superficielle.

Les facteurs déclenchants sont traumatisme, soleil, le froid, le stress, les milieux de dépression, les côtes humaines. Le diagnostic clinique est essentiellement clinique, les cultures, c'est le pèseur s'il y a un doute et le traitement viral peut être d'un apport très important. Voici une dendrite très typique et voici un ulcère géographique très typique comme on dit.

Les kératites épithéliales austériennes surviennent après un zona et on a ces kératites pseudo-dendritiques. Ce n'est pas les fameuses dendrites comme vous voyez sur l'image, ce n'est pas les fameuses dendrites de la kératite herpétique et ça survient essentiellement avec un zona ophtalmique. Nous avons aussi les kératites épithéliales bactériennes qui peut être un ulcère traumatique ou conjonctivite bactérienne.

Ils surviennent surtout après le port des lentilles de contact parce qu'il y a un développement des germes de façon très importante. Les facteurs favorisant, c'est les infections de voisinage, complications cellulaires, l'hypopiole, la perforation et le traitement, c'est les coulures antibiotiques, plus ou moins les corticoïdes pour le déconstruire de l'inflammation. Les germes responsables ce sont généralement Staphylococcus, Ipidermidis streptococcus, les bacillus graves positifs présents indépendamment des lentilles de contact, les bacillus graves négatifs, Piusillenicocci est très grave et le pneumococci risque élevé, de rapide fonte au QLA comme on voit sur ces images.

Voici un ulcère minime, voici un ulcère moyen avec une hypopiole, une perforation corneale, donc ça peut aller jusqu'à une atteinte plus grave. Le glaucome aiguë par fermeture de l'ongle, nous l'avons étudié au cours du chapitre des glaucomes. Il survient chez une patiente de 50 ans, urgence thérapeutique, douleur violente à irradiation périorbitaire avec hypertonie oculaire, gonioscopie l'ongle est fermée, l'examen de l'ADELF est très très important.

Le traitement médical par voie générale, Manitol 1 à 2 kg soit 100 à 200 ml en 15 minutes, la cytosolamide Diamox, la voie locale hypotonisant, les bêtas bloquants, les alpha-doagonistes, les inhibiteurs de l'anidrase carbonique, les choléroméotiques, diminution de tonus, corne éclairée, ongle ouvert. On peut prévoir donc une irréductomie au laser IAC et au largan chirurgical. On peut aussi l'utiliser parfois, on est obligé d'utiliser un traitement.

L'uvigyte antérieur peut atteindre les risques ancillaires, les signes fonctionnels de l'ore profonde temporale au frontal, baisse de l'acuité visuelle, importante photophobie à la lampe profonde, on peut trouver un cercle hyperhichératique, des précipités rétro-dysmythiques, un tendal, épopée, un cyniche, séclusion pupulaire et hypertonie oculaire. Le réflexe est diminué ou aboli et on peut parfois monter des modules aériens. L'évolution en possède avec des séquelles, type de cyniche et l'hydrochrySTALLINE.

L'étiologie 80% aucune, l'étiologie n'est retrouvée. L'infection inflammation locale, il peut être donc auto-immune, l'uvigyte, phaco-antigénique et l'ophtalmosympathique représentent une étiologie très importante. On peut avoir des maladies de système atype de spondylarthritis onculosante, polyarthrite polyméthylide ou le sarcoïdose, maladies métaboliques, la goutte et le diabète.

Le traitement est essentiellement fait de médiatiques cyclopligiques, corticoïdes locales et traitements étiologiques. Voici donc une uvigyte avec des cyniches et l'hydrochrySTALLINE. Voici des précipités rétro-cornaires.

Donc nous sommes dans l'œil rouge douloureux avec baisse de la QD visuelle, soit on n'a pas de contexte traumatique, soit on a un contexte traumatique. Traumatisme bénin, érosion corneille, chératite aiguë, corps étranger superficiel et corneille, traumatisme grave, plaies et contusions de globes oculaires, corps étranger intra-oculaire ou brûlure oculaire. Voici l'exemple d'une rougeur oculaire mais avec une hernie de l'iris et une plaie.

L'œil rouge est un ensemble nosologique qui représente beaucoup d'étiologies. Il faut savoir faire un interrogatoire précis, un diagnostic précis pour arriver à une étiologie. Certes, la majorité des étiologies de l'œil rouge sont des manifestations de l'œil, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des étiologies graves qu'il faut prendre en charge le plus précocement possible pour pouvoir les orienter rapidement pour une prise en charge, pour adapter et je vous remercie.